

Rối Loạn Cương Dương (ED)

Thông tin cho bệnh nhân · Tình trạng phổ biến, có thể điều trị — và là tín hiệu cảnh báo tim mạch

WARWIKI

Rối loạn cương dương (ED) là tình trạng khó đạt hoặc duy trì sự cương dương đủ cứng để quan hệ tình dục thỏa mãn, xảy ra thường xuyên đến mức gây phiền toái. Đây là tình trạng rất phổ biến và ngày càng tăng theo tuổi — đồng thời có thể điều trị hiệu quả cao. Vì sự cương dương phụ thuộc vào lưu lượng máu khỏe mạnh, ED cũng có thể là **dấu hiệu cảnh báo sớm** của bệnh tim và mạch máu, vì vậy cần được đánh giá.

Nguyên nhân

Sự cương dương cần mạch máu, dây thần kinh, hormone và tâm lý cùng phối hợp. ED thường có nhiều hơn một nguyên nhân:

- **Lưu lượng máu** (phổ biến nhất) — có chung các yếu tố nguy cơ với bệnh tim: đái tháo đường, tăng huyết áp, mỡ máu cao, hút thuốc lá và thừa cân.
- **Dây thần kinh** — sau phẫu thuật tuyến tiền liệt hoặc vùng chậu, đái tháo đường, hoặc bệnh lý cột sống.
- **Hormone** — testosterone thấp.
- **Thuốc và tâm lý** — một số loại thuốc, cộng với căng thẳng, lo âu, trầm cảm hoặc mâu thuẫn trong mối quan hệ.

Kiểm tra sức khỏe tim mạch

Vì các động mạch nhỏ ở dương vật có thể báo hiệu vấn đề trước tiên, ED mới xuất hiện là lý do tốt để kiểm tra huyết áp, đường huyết và mỡ máu — điều trị các yếu tố này giúp ích cho tim và sự cương dương của bạn.

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Rối loạn cương dương (ED)

Khó đạt hoặc duy trì sự cương dương đủ cứng để quan hệ.

Mạch máu (Vascular)

Liên quan đến lưu lượng máu — nguyên nhân phổ biến nhất của ED.

Thuốc ức chế PDE5

Nhóm thuốc uống điều trị ED hàng đầu (sildenafil, tadalafil, v.v.).

Thiết bị hút chân không (VED)

Bơm hút máu vào dương vật để tạo sự cương dương.

Tiêm thể hang (ICI)

Tự tiêm vào dương vật để tạo sự cương dương.

Bộ phận giả dương vật

Thiết bị phẫu thuật cho ED không đáp ứng các phương pháp khác.

CÓ CHỮA ĐƯỢC KHÔNG? Hầu như luôn luôn có — ED là một trong những tình trạng có thể điều trị nhất trong sức khỏe nam giới, với các lựa chọn từ thuốc uống đến thiết bị đến phẫu thuật. Điều trị theo **bậc thang**: bắt đầu đơn giản và chỉ tiến lên khi cần, và có lựa chọn hiệu quả ở mỗi mức.

Điều trị như thế nào (Từng bước)

- 1 Lối sống & sức khỏe** — tập thể dục, giảm cân, bỏ thuốc lá và kiểm soát đái tháo đường/huyết áp thực sự cải thiện sự cương dương; xem xét các thuốc có thể gây ảnh hưởng.
- 2 Thuốc uống (thuốc ức chế PDE5)** — thường là điều trị đầu tiên.
- 3 Thiết bị hút chân không, tiêm, hoặc viên đặt niệu đạo** — lựa chọn hiệu quả nếu thuốc uống không đủ.
- 4 Testosterone** nếu thấp; **tư vấn tâm lý** cho căng thẳng hoặc các yếu tố trong mối quan hệ.
- 5 Bộ phận giả dương vật** — lựa chọn phẫu thuật đáng tin cậy khi các phương pháp khác không hiệu quả. Mỗi lựa chọn có tờ thông tin riêng.

Đánh giá như thế nào

- Hỏi bệnh sử (bao gồm yếu tố nguy cơ tim mạch và các thuốc đang dùng) và khám lâm sàng
- Xét nghiệm máu — đường huyết, testosterone, mỡ máu

Nên biết thêm

- Giao tiếp cởi mở với bạn tình và điều trị lo âu/trầm cảm mang lại hiệu quả tốt.
- Hãy cảnh giác với các “thực phẩm chức năng” không được kiểm chứng bán trực tuyến — một số chứa thuốc ẩn.

Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- ED kèm **đau ngực** hoặc khó thở khi gắng sức — cần kiểm tra tim
- ED khởi phát **đột ngột sau chấn thương** vùng chậu hoặc dương vật
- Khi điều trị: sự cương dương kéo dài **hơn 4 giờ** (cấp cứu)

BA ĐIỀU CẦN NHỚ

- ED rất phổ biến và có thể điều trị cao, với lựa chọn hiệu quả ở mọi mức từ thuốc uống đến bộ phận giả.
- ED có thể là dấu hiệu sớm của bệnh tim/mạch máu — đánh giá toàn diện giúp cải thiện sức khỏe tổng thể, và thay đổi lối sống cải thiện sự cương dương.
- Hãy trao đổi với nhóm chăm sóc của bạn. Cần khám ngay nếu ED kèm đau ngực, hoặc sự cương dương kéo dài hơn 4 giờ khi điều trị.